

Faculté de Médecine de Monastir
Evaluation

Pathologie Médicale
Dr Syrine DAADAA

Splénomégalie
2025

- 1. Etablir le diagnostic positif d'une splénomégalie à partir des données cliniques et radiologiques.**

Concernant la palpation de la rate dans le diagnostic de la splénomégalie :

- A. Elle se fait de préférence avec le patient en décubitus dorsal, genoux fléchis pour relâcher la paroi abdominale.
- B. La masse palpée en cas de splénomégalie est fixe et insensible à la respiration.
- C. Le bord antérieur de la rate est crénelé.
- D. La palpation doit se faire en remontant depuis la fosse iliaque vers l'hypochondre gauche.
- E. Le débord splénique doit être mesuré avec un mètre ruban à partir du rebord costal sur la ligne mamelonnaire

Concernant la palpation de la rate dans le diagnostic de la splénomégalie :

- A. Elle se fait de préférence avec le patient en décubitus dorsal, genoux fléchis pour relâcher la paroi abdominale.
- B. La masse palpée en cas de splénomégalie est fixe et insensible à la respiration.
- C. Le bord antérieur de la rate est crénelé.
- D. La palpation doit se faire en remontant depuis la fosse iliaque vers l'hypochondre gauche.
- E. Le débord splénique doit être mesuré avec un mètre ruban à partir du rebord costal sur la ligne mamelonnaire

La mensuration d'une splénomégalie est appréciée:

A-En centimètre du rebord costal gauche

B- En travée de doigts du rebord costal

C- En centimètre de l'épine iliaque antéro-supérieure gauche

D- A partir de la dernière cote non flottante et sur la ligne médio-claviculaire

E- En combinant une percussion thoracique à une palpation abdominale

La mensuration d'une splénomégalie est appréciée:

A-En centimètre du rebord costal gauche

B- En travée de doigts du rebord costal

C- En centimètre de l'épine iliaque antéro-supérieure gauche

D- A partir de la dernière cote non flottante et sur la ligne médio-claviculaire

E- En combinant une percussion thoracique à une palpation abdominale

L'échographie abdominale est utile pour le dg positif d'une splénomégalie dans les situations suivantes:

A- ascite

B- sujet âgé

C- paroi abdominale tonique

D- obésité

E- enfant

L'échographie abdominale est utile pour le dg positif d'une splénomégalie dans les situations suivantes:

A- ascite

B- sujet âgé

C- paroi abdominale tonique

D- obésité

E- enfant

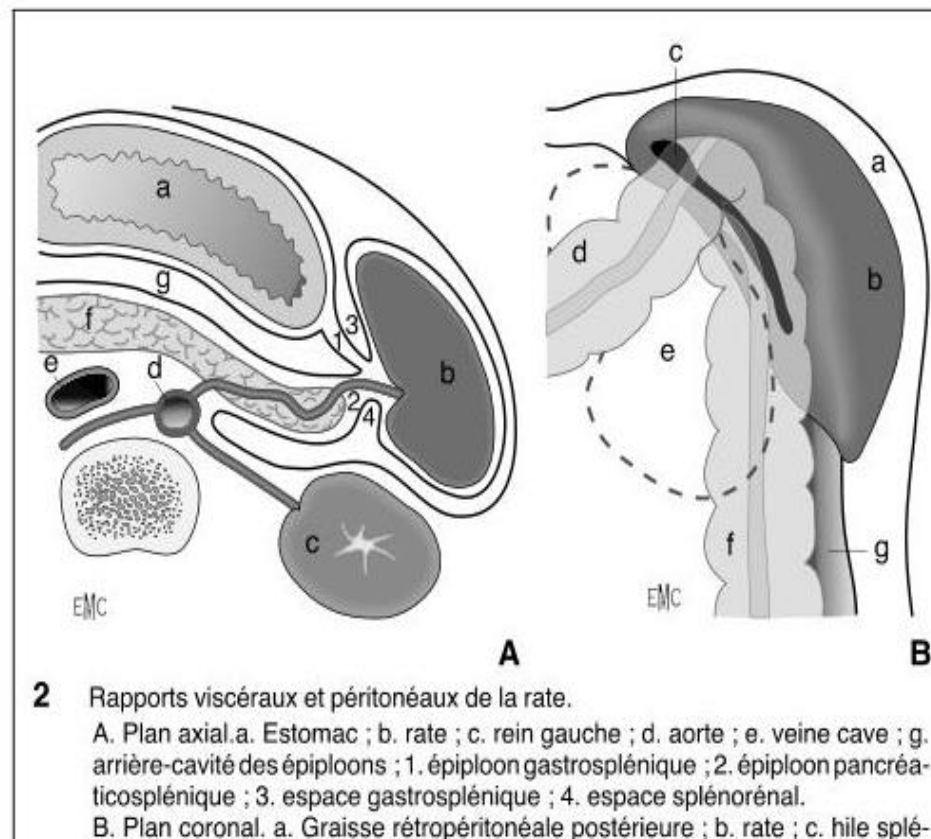
L'échographie abdominale dans l'évaluation de la splénomégalie :

- A. Confirme la nature splénique d'une masse palpée.
- B. Différencie un kyste splénique d'un hématome.
- C. Visualise des signes d'hypertension portale.
- D. Considère la splénomégalie retenue si la flèche échographique est ≥ 15 cm.
- E. Peut être réalisée même en cas d'ascite ou d'obésité.

L'échographie abdominale dans l'évaluation de la splénomégalie :

- A. Confirme la nature splénique d'une masse palpée.
- B. Différencie un kyste splénique d'un hématome.
- C. Visualise des signes d'hypertension portale.
- D. Considère la splénomégalie retenue si la flèche échographique est ≥ 15 cm.
- E. Peut être réalisée même en cas d'ascite ou d'obésité.

- Organe de consistance **molle et friable**, la rate n'a pas de forme propre : elle se moule sur les organes de voisinage.
- C'est un **organe lymphoïde**, étroitement lié au système porte
- Dimensions: 12 cm de hauteur; 8 cm d'épaisseur; 200 grammes

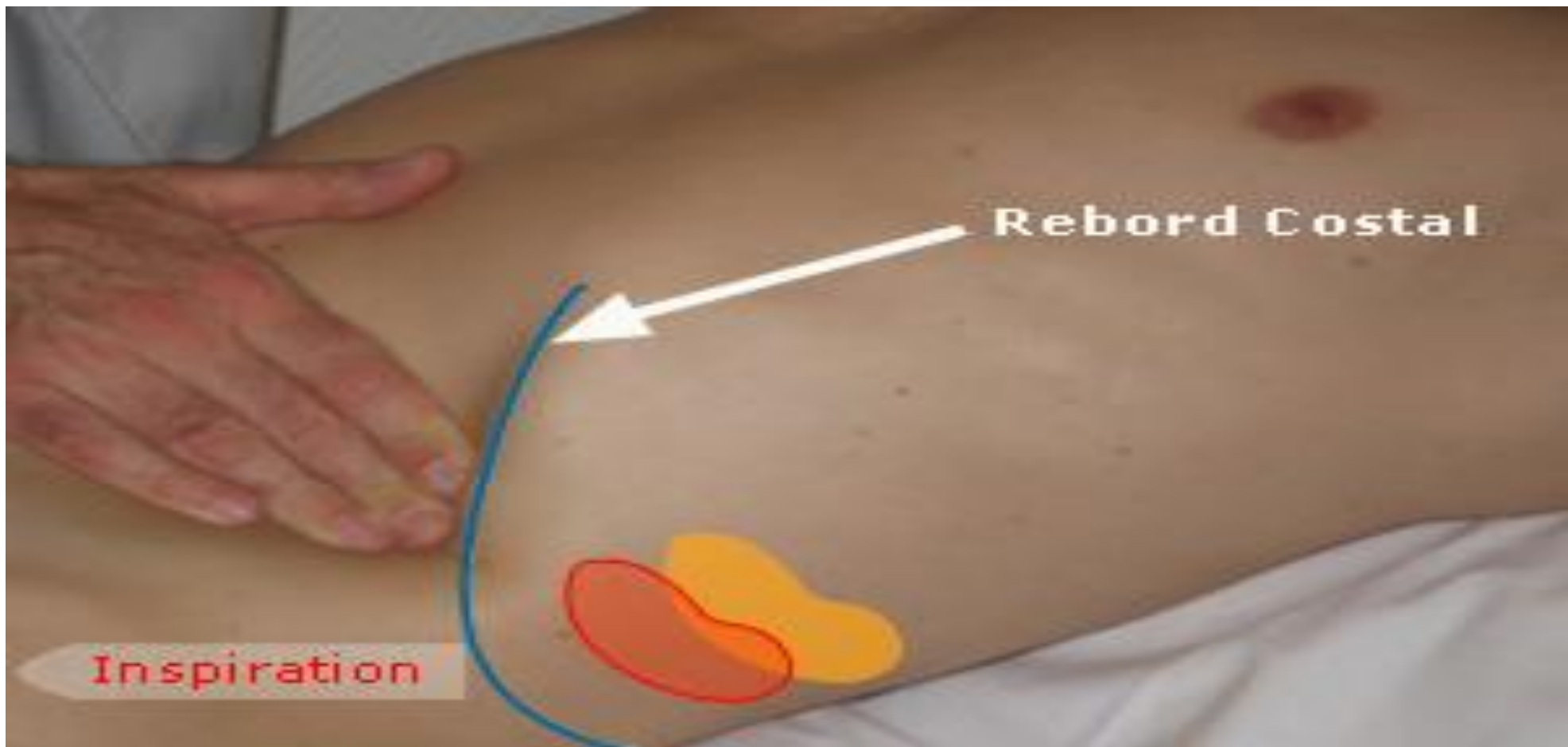


Diagnostic Clinique

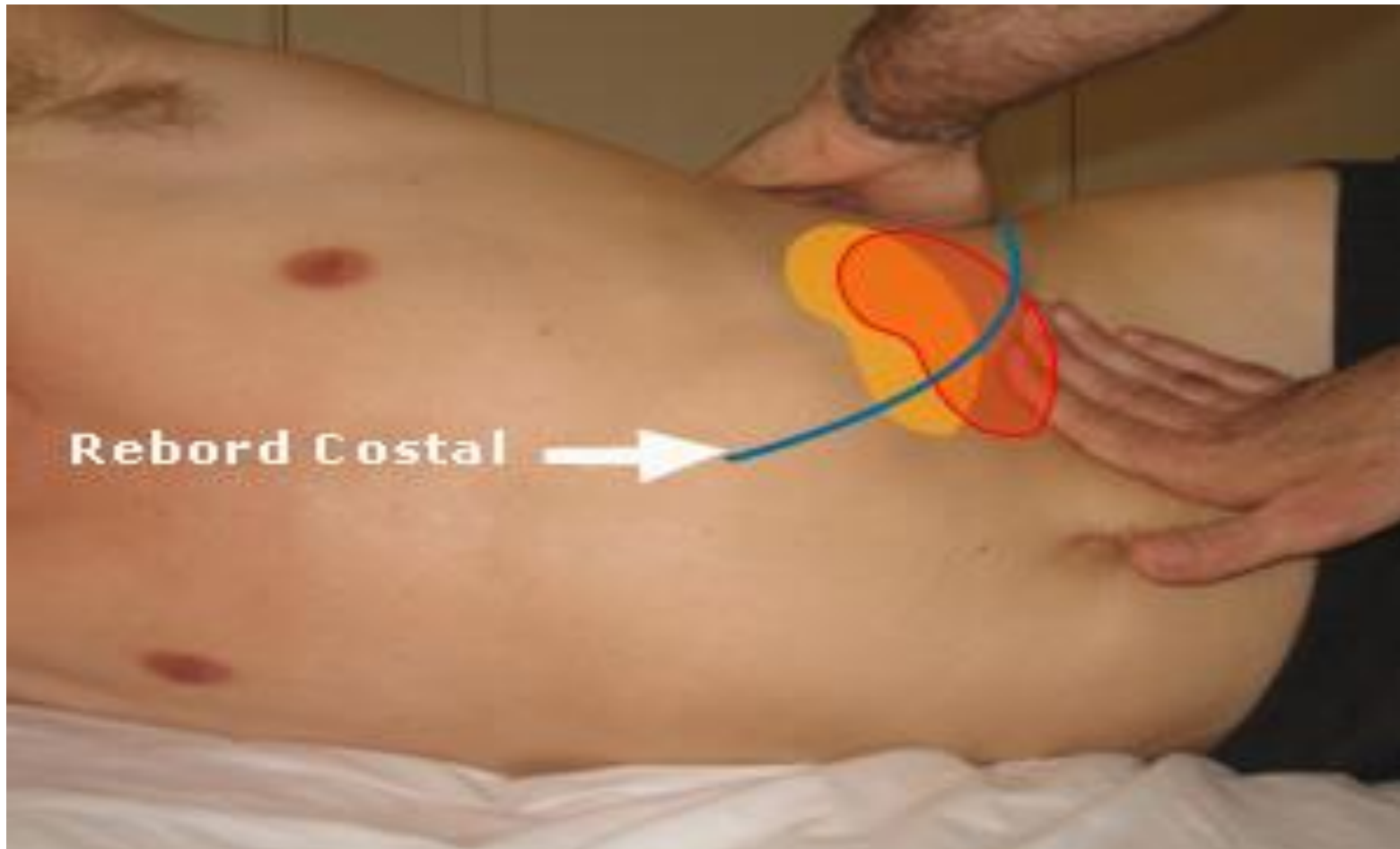
- Toute rate palpable est pathologique
- palpation en décubitus dorsal ou latéral droit:
 - masse de l'hypochondre gauche, antérieure, superficielle, plus ou moins externe,
 - extrémité inférieure palpable
 - bord antérieur crénelé
 - mobile avec la respiration, s'abaissant à l'inspiration.
 - mate à la percussion

→ ***Patient en décubitus dorsal***

Jambes fléchies, paroi abdominale détendue ; examinateur à droite, main à plat sur l'abdomen déprimant doucement la paroi.



- ***Patient en décubitus latéral droit***



- Imagerie: non indispensable pour confirmer la SMG
- Utilité: en cas de doute ou dans les cas difficiles (ascite, obésité, paroi abdominale tonique)
- Échographie:
 - taille de la rate **(SMG si flèche échographique ≥ 13 cm)**
 - structure de la rate (homogène ou non)
 - éventuelles anomalies associés (hépatomégalie, adénopathies profondes, signes d'hypertension portale)

2- Expliquer les mécanismes physiopathologiques à l'origine d'une splénomégalie.

Une splénomégalie pourrait être en rapport avec:

A- Une hyperplasie splénique

B- Une augmentation de la séquestration des globules rouges

C- Une congestion par hypertension artérielle

D- Une infiltration tumorale

E- Un dépôt de substances ou de cellules

Une splénomégalie pourrait être en rapport avec:

A- Une hyperplasie splénique

B- Une augmentation de la séquestration des globules rouges

C- Une congestion par hypertension artérielle

D- Une infiltration tumorale

E- Un dépôt de substances ou de cellules

Les conséquences de la splénomégalie sont

- A. L'hypersplénisme
- B. La polyglobulie
- C. L'hyperplaquettose
- D. L'hémodilution
- E. L'hypertension portale d'apport

Les conséquences de la splénomégalie sont

A. L'hypersplénisme

B. La polyglobulie

C. L'hyperplaquettose

D. L'hémodilution

E. L'hypertension portale d'apport

La rate a comme rôle physiologique :

- A- Destruction des globules rouges vieillis
- B- a une fonction immunitaire surtout contre les virus
- C- Elaboration d'une réponse humorale
- D- Production du complément
- E- production des monocytes

La rate a comme rôle physiologique :

- A- Destruction des globules rouges vieillis
- B- A une fonction immunitaire surtout contre les virus
- C- Elaboration d'une réponse humorale
- D- Production du complément
- E- production des monocytes

Principales fonctions de la rate

- **Organe lymphoïde** impliqué dans l'élaboration de la **réponse immune humorale** : synthèse rapide d'Ac et IgM lors de la réponse immunitaire primaire
- **Organe myéloïde** responsable de la **clairance sanguine des hématies** sénescents ou recouvertes d'Ac, et de l'élimination de débris cellulaires et microorganismes.
- **Organe très vascularisé** : Son drainage vasculaire s'effectue vers le **système porte**.
- **Rôle de stockage** des plaquettes (1/3 du pool plaquettaire), du fer, du facteur VIII.

Le développement d'une splénomégalie résulte :

- soit d'une **augmentation de pression dans le système porte**
- soit d'une hyperplasie ou d'une hypertrophie du **système macrophagique**
- soit d'une **hyperplasie lymphoïde**
- soit d'une **métaplasie myéloïde**.
- soit d'une **infiltration tumorale** (tissu lymphoïde, myéloïde ou autre)

Quelque qu'en soit la cause

⇒ hypersplénisme

- lié à la séquestration splénique anormale des hématies et des leucocytes et accrue pour les plaquettes
- se traduit par une (des) cytopénie(s) modérée(s) sans conséquence propre

⇒ hémodilution

fausse anémie (intérêt éventuel de la masse sanguine)

⇒ hypertension portale « d'apport », si rate très volumineuse

⇒ diminution des taux de facteur V et de cholestérol

- **3. Décrire les circonstances de découverte d'une splénomégalie.**

Le diagnostic positif d'une splénomégalie repose sur :

A- Anamnèse

B- Examen physique

C- Echographie abdominale

D- Biopsie splénique

E- Biologie

Le diagnostic positif d'une splénomégalie repose sur :

A- Anamnèse

B- Examen physique

C- Echographie abdominale

D- Biopsie splénique

E- Biologie

Les situations suivantes doivent rechercher à l'examen clinique une splénomégalie:

- A- sensation pesanteur ou douleur de l'hypochondre droit
- B- fièvre avec adénopathie chez un patient de retour de zone endémique
- C- douleur hypochondre gauche suite à un AVP
- D- présence d'une pancytopénie à la NFS
- E – présence d'ictère et d'ascite à l'examen

Les situations suivantes doivent rechercher à l'examen clinique une splénomégalie:

- A- sensation pesanteur ou douleur de l'hypochondre droit
- B- fièvre avec adénopathie chez un patient de retour de zone endémique
- C- douleur hypochondre gauche suite à un AVP
- D- présence d'une pancytopénie à la NFS
- E – présence d'ictère et d'ascite à l'examen

Une splénomégalie peut être découverte devant

- A. Une sensation de pesanteur de l'hypochondre gauche
- B. Un examen clinique systématique de façon fortuite
- C. Une fièvre prolongée
- D. Un infarctus splénique
- E. Un vitiligo

Une splénomégalie peut être découverte devant

- A. Une sensation de pesanteur de l'hypochondre gauche
- B. Un examen clinique systématique de façon fortuite
- C. Une fièvre prolongée
- D. Un infarctus splénique
- E. Un vitiligo

- Le plus souvent **de façon fortuite** (splénomégalie est indolore)
ou devant un signe clinique : Fièvre prolongée
Hépatomégalie
Adénopathies
Ictère

NFS systématique

- *Troubles fonctionnels :*

- ✓ Pesanteur de l'hypochondre gauche
- ✓ Douleur abdominale
- ✓ Constipation, troubles dyspeptiques

- *Complications :*

- ✓ Infarctus splénique : douleur du flanc/basithoracique
- ✓ Rupture de la rate : choc hémorragique +douleur
- ✓ Hypersplénisme : pancytopénie

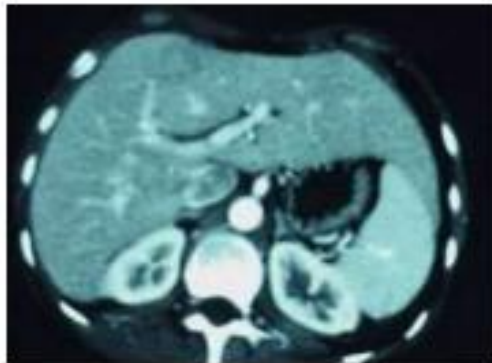
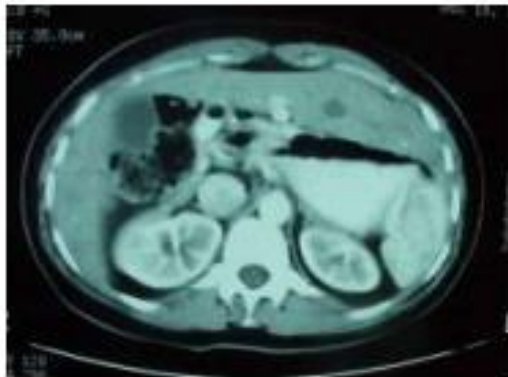
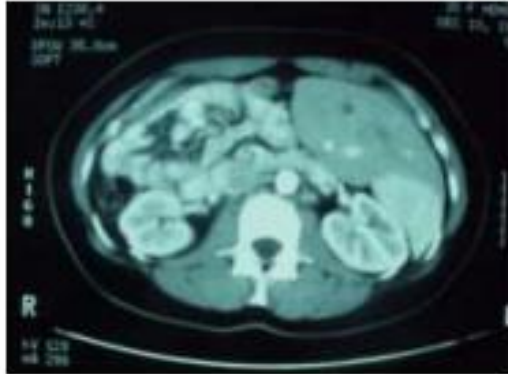
4. Différencier par l'examen clinique et l'imagerie médicale une splénomégalie d'une autre masse de l'hypochondre gauche.

Devant une masse de l'hypochondre gauche, la splénomégalie fait le diagnostic différentiel avec :

- A. Un gros rein gauche
- B. Une côte surnuméraire
- C. Une tumeur du côlon transverse
- D. Une hypertrophie du lobe gauche du foie
- E. Une tumeur de la tête du pancréas

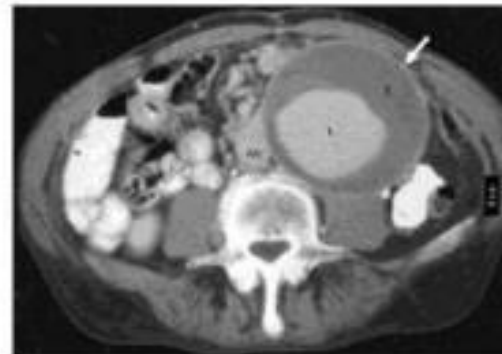
Devant une masse de l'hypochondre gauche, la splénomégalie fait le diagnostic différentiel avec :

- A. Un gros rein gauche**
- B. Une côte surnuméraire
- C. Une tumeur du côlon transverse
- D. Une hypertrophie du lobe gauche du foie**
- E. Une tumeur de la tête du pancréas



B - DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- ◆ *gros rein gauche*
 mais ↗ + AR + contact lombaire
 ↘ immobile à l'inspiration
- ◆ *tumeur angle colique G AV*
 mais ↗ immobile sans incisures
 ↘ pôle inférieur mal limité
- ◆ *kyste du mésentère*
- ◆ *kyste ou tumeur de la queue du pancréas*
- ◆ *une tumeur gastrique*
- ◆ *lobe gauche hépatique*



5. Réunir les arguments anamnestiques et cliniques permettant l'orientation du diagnostic étiologique en fonction de l'âge.

En faveur d'une splénomégalie infectieuse, vous reprenez :

A- Fièvre et altération de l'état générale

B- Notion de contagion

C- Syndrome inflammatoire biologique

D- Association à des adénopathies volumineuses

E- aspect nodulaire à l'imagerie abdominale

En faveur d'une splénomégalie infectieuse, vous reprenez :

A- Fièvre et altération de l'état générale

B- Notion de contagion

C- Syndrome inflammatoire biologique

D- Association à des adénopathies volumineuses

E- aspect nodulaire à l'imagerie abdominale

Parmi les éléments suivants, quels sont ceux en faveur d'une splénomégalie par hypertension portale :

A - Circulation collatérale abdominale

B – Ascite

C - Hépatomégalie

D - Notion d'hématémèses

E - Eruption cutanée

Parmi les éléments suivants, quels sont ceux en faveur d'une splénomégalie par hypertension portale :

A - Circulation collatérale abdominale

B – Ascite

C - Hépatomégalie

D - Notion d'hématémèses

E - Eruption cutanée

Au cours d'une splénomégalie infectieuse bactérienne, vous pouvez noter :

- A. Une porte d'entrée est peut être trouvée
- B. Un syndrome septicémique (fièvre + AEG)
- C. Un syndrome inflammatoire biologique franc
- D. Un état général conservé
- E. Une hépatomégalie constante

Au cours d'une splénomégalie infectieuse bactérienne, vous pouvez noter :

- A. Une porte d'entrée est peut être trouvée
- B. Un syndrome septicémique (fièvre + AEG)
- C. Un syndrome inflammatoire biologique franc
- D. Un état général conservé
- E. Une hépatomégalie constante

Au cours d'une splénomégalie infectieuse au cours d'une leishmaniose viscérale, vous pouvez noter :

- A. Fièvre anarchique
- B. une infection à VIH associée
- C. ictère fébrile
- D. un état général conservé
- E. Diarrhée

Au cours d'une splénomégalie infectieuse au cours d'une leishmaniose viscérale, vous pouvez noter :

A. Fièvre anarchique

B. une infection à VIH associée

C. ictère fébrile

D. un état général conservé

E. Diarrhée

Une splénomégalie fébrile avec leuco-neutropénie vous évoque :

- A. Une brucellose.
- B. Une fièvre typhoïde.
- C. Une candidose viscérale.
- D. Une mononucléose infectieuse.
- E. Une rickettsiose.

Une splénomégalie fébrile avec leuco-neutropénie vous évoque :

- A. Une brucellose.
- B. Une fièvre typhoïde.
- C. Une candidose viscérale.
- D. Une mononucléose infectieuse.
- E. Une rickettsiose.

En faveur d'une splénomégalie par infection virale, vous retenir :

A- circulation collatérale abdominale

B- Ascite

C- adénopathies

D- notion d'hématémèses

E- Eruption cutanée

En faveur d'une splénomégalie par infection virale, vous retenez :

A- circulation collatérale abdominale

B- Ascite

C- adénopathies

D- notion d'hématémèses

E- Eruption cutanée

**En faveur d'une splénomégalie par Primo-infection à HIV,
vous retenez :**

A-Splénomégalie volumineuse

B-Polyadénopathie

C- éruption cutanée

D-diarrhée prolongée

E-fièvre et sueurs nocturnes

**En faveur d'une splénomégalie par Primo-infection à HIV,
vous retenez :**

A-Splénomégalie volumineuse

B-Polyadénopathie

C- éruption cutanée

D-diarrhée prolongée

E-fièvre et sueurs nocturnes

**Une splénomégalie avec adénopathies cervicales
vous oriente vers :**

A-Un myélome multiple.

B-Une leucémie aigue.

C-Une mononucléose infectieuse.

D-Une cirrhose hépatique.

E-Un lupus systémique

Une splénomégalie avec adénopathies cervicales vous oriente vers :

A-Un myélome multiple.

B-Une leucémie aigue.

C-Une mononucléose infectieuse.

D- Une cirrhose hépatique.

E-Un lupus érythémateux systémique systémique

Le syndrome de Felty associe:

A- Une splénomégalie

B- Un érythème du visage

C- Une neutropénie profonde

D- Des adénopathies médiastinales

E- Une polyarthrite Rhumatoïde

Le syndrome de Felty associe:

A- Une splénomégalie

B- Un érythème du visage

C- Une neutropénie profonde

D- Des adénopathies médiastinales

E- Une polyarthrite Rhumatoïde

La maladie de still est caractérisée par

- A. Une splénomégalie modérée
- B. Une hyperferritinémie
- C. Une baisse de la fraction glycosylée de la ferritine
- D. Une fièvre en plateau
- E. Des arthrites

La maladie de still est caractérisée par

- A. Une splénomégalie modérée
- B. Une hyperferritinémie
- C. Une baisse de la fraction glycosylée de la ferritine
- D. Une fièvre en plateau
- E. Des arthrites

La ou es situations suivantes peut/peuvent donner une SMG:

A-Anémie de Biermer

B- hémangiome splénique

C- kyste hydatique de la rate

D- Le myélome multiple

E- lymphome splénique

La ou es situations suivantes peut/peuvent donner une SMG:

A-Anémie de Biermer

B- hémangiome splénique

C- kyste hydatique de la rate

D- Le myélome multiple

E- lymphome splénique

La fièvre Typhoïde associe :

A- Une splénomégalie

B- Une leucopénie

C- Une fièvre anarchique

D- Une sérologie de Wright positive

E- Une angine à fausse membrane

La fièvre Typhoïde associe :

A- Une splénomégalie

B- Une leucopénie

C- Une fièvre anarchique

D- Une sérologie de Wright positive

E- Une angine à fausse membrane

En présence d'une Splénomégalie , le diagnostic de syndrome d'activation macrophagique sera évoqué devant:

- A. un contexte de déficit immunitaire
- B. Absence de fièvre
- C. une hypertriglycémie
- D. des images d'hémophagocytose dans les macrophages médullaires
- E. une hypofibrinogénémie

En présence d'une Splénomégalie , le diagnostic de syndrome d'activation macrophagique sera évoqué devant:

- A. un contexte de déficit immunitaire**
- B. Absence de fièvre
- C. une hypertriglycémie**
- D. des images d'hémophagocytose dans les macrophages médullaires**
- E. une hypofibrinogénémie

Une splénomégalie volumineuse est retrouvée dans les situations suivantes:

- A. syndrome myeloproliférative
- B. infections virale
- C. leishmaniose
- D. maladie de surcharge
- E. septicémie bactérienne

Une splénomégalie volumineuse est retrouvée dans les situations suivantes:

A. syndrome myeloproliférative

B. infections virale

C. leishmaniose

D. maladie de surcharge

E. septicémie bactérienne

Une splénomégalie avec adénopathies cervicales vous oriente vers :

- A. Un myélome multiple.
- B. Une leucémie aigue.
- C. Une mononucléose infectieuse.
- D. Une cirrhose hépatique.
- E. Une sarcoïdose

Une splénomégalie avec adénopathies cervicales vous oriente vers :

- A. Un myélome multiple.
- B. Une leucémie aigue.**
- C. Une mononucléose infectieuse.**
- D. Une cirrhose hépatique.
- E. Une sarcoïdose**

masse de l' hypochondre gauche

NFS = hypersplénisme
(thrombopénie modérée)

splénomégalie

ORIENTATION

âge, origine ethnique, lieux de séjour?

tableau infectieux?

hépatomégalie? signes d'hypertension portale?

polyadénopathie?

hémogramme?

électrophorèse des protides sanguins?

imagerie de la rate: échographie, scanner

contexte infectieux

septicémie à pyogènes
endocardite lente (mal. d'Osler)
brucellose, typhoïde
tuberculose hématopoïétique

MNI, hépatite virale
HIV (ARC)
paludisme
leishmaniose (kala-azar)
trypanosomiase

hypertension portale

cirrhose alcoolique, post-hépatitique, CBP
bilharziose, maladie de Wilson,

Budd Chiari, insuffisance cardiaque

thrombose ou atésie veine porte
HTP segmentaire (pancréas)

isolée

étude phénotypique lymphocytes
sanguins, biopsie médullaire,
biopsie hépatique

lymphome splénique
maladie de surcharge: Gaucher
tumeur primitive de la rate
"idiopathique"

pas de diagnostic

discuter
splénectomie à
visée
diagnostique

associée à une (poly)adénopathie

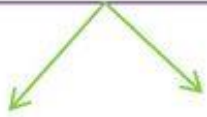
maladie de Hodgkin
lymphome non Hodgkinien
maladies virales: MNI, VIH
maladie de système: LED, PR, sarcoïdose,
maladie périodique

hémogramme pathologique

"lymphocytose"	LLC et autres sd lymphoprolifératifs chroniques leucémie à tricholeucocytes lymphome splénique à lymphocytes villeux
myélémie	sd myéloprolifératif: LMC, SMM
polyglobulie	maladie de Vaquez
hyperhémolyse	anémies hémolytiques - acquises: AH auto-immunes - congénitales: hémoglobinopathies, microsphérocytose
blastés	leucémies aiguës (lymphoblastiques surtout)

Syndrome splénomégalique

Signes cliniques associés



Fièvre

- Septicémie
- Endocardite
- Tuberculose
- VIH
- MNI

HTP

- Cirrhose
- Autres causes

Contexte d'hémopathie



- Lymphome
- LMC
- LLC
- Anémies hémolytiques
- Maladie de Vaquez

Isolée



- Infiltrations et surcharge
- Tumeurs
- ...

Étiologie des splénomégalias selon le mécanisme physiopathologique	
Fonction macrophagique (ou de filtre macrophagique)	-Pathologies infectieuses bactériennes, virales, parasitaires -Pathologies inflammatoires - Hémolyses chroniques constitutionnelles ou acquises du globule rouge -Maladies de surcharge
Fonction de filtre vasculaire	Lésion ou obstacle préhépatique, intrahépatique ou posthépatique
Fonction hématopoïétique	- Syndromes myéloprolifératifs - Syndromes lymphoprolifératifs - Leucémies aiguës
Divers	Traumatismes, kystes, hémangiome, métastases de tumeurs solides...

Causes de Splénomégalie = CHIPSTER !

- C : **C**ollagénoses (maladies de système)
- H : **H**émopathies (lymphoïdes et myéloïdes)
- I : **I**nfections (B, V, P, F)
- P : Hypertension **P**ortale
- S : Maladies de **S**urcharge
- T : **T**umeurs de rate
- E : **E**ndocardite!
- R : **R**égénératif (anémies hémolytiques chroniques)

6. Planifier les examens complémentaires à réaliser chez un patient présentant une splénomégalie, en fonction de l'orientation étiologique.

La confirmation d'une leishmaniose viscérale repose sur :

A. Myélogramme

B. PCR

C. Sérologie de la leishmaniose

D. Electrophorèse des protides

E. Hémogramme

La confirmation d'une leishmaniose viscérale repose sur :

A. Myélogramme

B. PCR

C. Sérologie de la leishmaniose

D. Electrophorèse des protides

E. Hémogramme

Pour confirmer le diagnostic d'un kyste hydatique de la rate on demande :

- A. Sérologie hydatique
- B. Bilan hépatique
- C. Myélogramme
- D. Echographie abdominale
- E. Abdomen sans préparation

Pour confirmer le diagnostic d'un kyste hydatique de la rate on demande :

A. Sérologie hydatique

B. Bilan hépatique

C. Myélogramme

D. Echographie abdominale

E. Abdomen sans préparation

Un malade âgé de 20 ans suivi pour une maladie Bechet présente des douleurs abdominales depuis 1 mois associées une SMG , ce tableau clinique évoque:

A- septicémie

B- Leucémie Aigue

C- Leishmaniose viscérale

D- Lymphome Malin

E-syndrome de Buddchiari

Un malade âgé de 20 ans suivi pour une maladie Bechet présente des douleurs abdominales depuis 1 mois associées une SMG , ce tableau clinique évoque:

A- septicémie

B- Leucémie Aigue

C- Leishmaniose viscérale

D- Lymphome Malin

E-syndrome de Buddchiari

Avant d'effectuer splénectomie il faut réaliser une vaccination :

A. Anti-hépatite B

B. Anti-pneumococcique

C. Anti-tétanique

D. B.C.G.

E. Anti-grippale

Avant d'effectuer splénectomie il faut réaliser une vaccination :

A. Anti-hépatite B

B. Anti-pneumococcique

C. Anti-tétanique

D. B.C.G.

E. Anti-grippale

Devant une splénomégalie dans un contexte fébrile, on peut évoquer une ou plusieurs des pathologies suivantes:

- A. Une angine à streptocoques
- B. Un lymphome malin non hodgkinien
- C. Une endocardite infectieuse
- D. Un lupus érythémateux systémique
- E. Un syndrome de Felty

Devant une splénomégalie dans un contexte fébrile, on peut évoquer une ou plusieurs des pathologies suivantes:

- A. Une angine à streptocoques
- B. Un lymphome malin non hodgkinien
- C. Une endocardite infectieuse
- D. Un lupus érythémateux systémique
- E. Un syndrome de Felty

Cas clinique N° 1

Un patient de 10 ans, consulte pour fièvre, sueurs nocturnes évoluant depuis 3 mois. L'examen révèle une splénomégalie de 10 cm douloureuse avec ascite de faible abondance, une hépatomégalie (FH : 15 cm), absence d'adénopathies périphériques.

Le bilan biologique montre :

Hb : 9g/dl, VGM : 82 μm^3 , TCMH : 27 pg ; Réticulocytes : 56000/mm³, GB = 3200 /mm³, PNN = 1000/mm³, Lymphocytes = 1500/mm³, Plaquettes = 90 000/mm³ ;
CRP = 150 mg/L.

A ce stade quel diagnostic(s) évoquez-vous chez ce patient :

A- Une tuberculose des organes hématopoïétiques.

B- leishmaniose .

C- Une fièvre typhoïde.

D- Une leucémie myéloïde chronique.

E- Une mononucléose infectieuse.

A ce stade quel diagnostic(s) évoquez-vous chez ce patient :

A- Une tuberculose des organes hématopoïétiques.

B- leishmaniose .

C- Une fièvre typhoïde.

D- Une leucémie myéloïde chronique.

E- Une mononucléose infectieuse.

La reprise de l'interrogatoire a retrouvé une notion de consommation de lait cru. Vous reprenez comme diagnostic :

- a) Une tuberculose des organes hématopoïétiques.
- b) leishmaniose.
- c) Une fièvre typhoïde.
- d) Une leucémie myéloïde chronique.
- e) Une mononucléose infectieuse

La reprise de l'interrogatoire a retrouvé une notion de consommation de lait cru. Vous retenir comme diagnostic :

- a) Une tuberculose des organes hématopoïétiques.**
- b) leishmaniose.
- c) Une fièvre typhoïde.
- d) Une leucémie myéloïde chronique.
- e) Une mononucléose infectieuse

Les examens complémentaires à demander pour confirmer votre diagnostic sont :

- a) IDR à la tuberculine
- b) Myélogramme avec myéloculture
- c) Ponction biopsie hépatique
- d) IRM abdominale
- e) PCR BK sur myélogramme

Les examens complémentaires à demander pour confirmer votre diagnostic sont :

- a) IDR à la tuberculine
- b) Myélogramme avec myéloculture
- c) Ponction biopsie hépatique
- d) IRM abdominale
- e) PCR BK sur myélogramme

Cas clinique 2

- Mme S âgée de 34 ans, sans antécédents pathologiques notables, vous consulte pour des arthralgies inflammatoires évoluant depuis 6 mois
- A l'interrogatoire, elle rapportait la notion de photosensibilité et un phénomène de Raynaud.
- L'examen physique révèle une température à 38°C, des arthrites au niveau de poignet droit et de la cheville gauche ainsi qu'une tuméfaction superficielle et mobile à la respiration au niveau de l'hypochondre gauche. Le reste de l'examen était sans particularités.

- Biologie: **VS**=70 (H1) **CRP**= 6 mg/l **Creat**=60umol/l

NFS: Hb=9g/dl VGM=82 TCMH=28 Rétic=70000/mm³

- GB=3100/mm³ lymph=1100/mm³ PNN=1700/mm³ , plaquette: 100 000/mm³

Les caractéristiques sémiologiques de la tuméfaction de l'hypochondre gauche objectivée chez notre patiente correspondent à :

- A. Une tumeur de l'angle colique gauche
- B. Un gros rein gauche
- C. Une grosse rate
- D. Un lobe gauche du foie hypertrophié
- E. Une tumeur de la queue de pancréas

Les caractéristiques sémiologiques de la tuméfaction de l'hypochondre gauche objectivée chez notre patiente correspondent à :

A. Une tumeur de l'angle colique gauche

B. Un gros rein gauche

C. Une grosse rate

D. Un lobe gauche du foie hypertrophié

E. Une tumeur de la queue de pancréas

Devant ce tableau, le bilan minimal de première intention doit comprendre :

A. Bilan hépatique complet

B. Dosage des LDH

C. Bilan phospho-calcique

D. Dosage de fibrinogène

E. Groupe sanguin

Devant ce tableau, le bilan minimal de première intention doit comprendre :

A. Bilan hépatique complet

B. Dosage des LDH

C. Bilan phospho-calcique

D. Dosage de fibrinogène

E. Groupe sanguin

Parmi ces diagnostics, quels sont les deux les plus probables:

- A. Une sarcoïdose
- B. Une tuberculose hématopoïétique
- C. Une endocardite infectieuse
- D. Une septicémie à pyogène
- E. Un lupus érythémateux systémique

Parmi ces diagnostics, quels sont les deux les plus probables:

A. Une sarcoïdose

B. Une tuberculose hématopoïétique

C. Une endocardite infectieuse

D. Une septicémie à pyogène

E. Un lupus érythémateux systémique

Afin d'étayer le diagnostic, les examens complémentaires qu'il faut réaliser sont :

- A. Echographie abdominale
- B. Echographie cardiaque trans-thoracique
- C. AAN
- D. Sérologies VHB/VHC
- E. Bilan tuberculeux

Afin d'étayer le diagnostic, les examens complémentaires qu'il faut réaliser sont :

A. Echographie abdominale

B. Echographie cardiaque trans-thoracique

C. AAN

D. Sérologies VHB/VHC

E. Bilan tuberculeux

Cas clinique 3

Une femme 63 ans est hospitalisée dans votre service pour fièvre. Depuis 15 jours elle présente une aggravation avec asthénie sévère, nausées, fièvre à 38°5 et sueurs profuses.

A l'examen vous trouvez une tachycardie à 108/mn, une TA à 105/70 mmHg, une Splénomégalie et une pâleur intense. L'auscultation pulmonaire est normale, l'auscultation cardiaque retrouve un souffle prothétique mitral. L'examen de l'abdomen est normal.

ATCD: une phlébite , ablation de 2 polypes du sigmoïde il y a 7 ans, et prothèse valvulaire mécanique mitrale il y a 5 ans sur insuffisance mitrale dystrophique sévère.

Depuis 5 mois, la patiente présente une asthénie avec perte de poids de 4 kg et troubles du transit associée à des douleurs abdominales intermittentes.

1/Quel diagnostic devez-vous évoquer en premier?

A- endocardite infectieuse

B-septicémie

C- syndrome myéloproliférative

D-infection virale

E- cancer colique

1/Quel diagnostic devez-vous évoquer en premier?

A- endocardite infectieuse

B-septicémie

C- syndrome myéloproliférative

D-infection virale

E- cancer colique

2-Quels examens demandez-vous afin de l'affirmer

A- hémoculture et échographie cardiaque

B- NFS

C- électrophorèse des protéines

D-sérologies virales

E- colonoscopie avec biopsie

2-Quels examens demandez-vous afin de l'affirmer

A- hémoculture et échographie cardiaque

B- NFS

C- électrophorèse des protéines

D-sérologies virales

E- colonoscopie avec biopsie

Une TDM TAP à montré une SMG avec foyer d'infarctissement. Des hémocultures positif à E.Coli et à l'échographie une végétation au niveau de la valve mitrale.

Le dg d'une endocardite infectieuse était retenu quelle serait la porte d'entrée

A- dentaire

B- digestive

C-cutanée

D- pulmonaire

E- urinaire

Une TDM TAP à montré une SMG avec foyer d'infarctissement. Des hémocultures positif à E.Coli et à l'échographie une végétation au niveau de la valve mitrale.

Le dg d'une endocardite infectieuse était retenu quelle serait la porte d'entrée

A- dentaire

B- digestive

C-cutanée

D- pulmonaire

E- urinaire

Cas clinique 4

Mme A âgée de 32 ans consulte pour des polyarthralgies inflammatoires des grosses articulations depuis 1 mois et une fièvre évoluant depuis plus que 3 semaines. A l'examen, la température était à 38,7°C, l'auscultation cardiaque et pulmonaire étaient sans anomalies. On ne trouvait pas d'arthrite ou d'éruption cutanée. La palpation abdominale révèle une masse de l'hypocondre gauche mobile avec la respiration évoquant une splénomégalie. A la biologie, la CRP= 28mg/l, VS= 82 mm, NFS= Hb= 8,7g/dl, VGM = 72 fl, plaquettes= 220 000 elt/mm³ , GB= 3200 elt/mm³ , Lym= 1000 elt/mm³, PNN= 2200 elt/mm³

Chez cette patiente vous suspectez :

- A. Une septicémie à pyogène
- B. Une mononuléose infectieuse
- C. Une fièvre typhoïde
- D. Une brucellose
- E. Un lupus erythémateux systémique

Chez cette patiente vous suspectez :

- A. Une septicémie à pyogène
- B. Une mononuléose infectieuse
- C. Une fièvre typhoïde
- D. Une brucellose**
- E. Un lupus erythémateux systémique**

vous allez demander les explorations suivantes :

A. Sérologie de Wright

B. Sérologie de Widal

C. AAN

D. Echographie abdominale

E. Protéinurie de 24h

vous allez demander les explorations suivantes :

A. Sérologie de Wright

B. Sérologie de Widal

C. AAN

D. Echographie abdominale

E. Protéinurie de 24h

L'évolution de la patiente était marquée par l'apparition de lésions ecchymotiques diffuses avec persistance d'une fièvre prolongée. Un bilan biologique fait a montré :

- NFS : Hb= 7g/dl, VGM= 70fl, plq= 30 000, GB=2000, Ly= 800, PNN= 1200
- TP= 40%, TCA= 1,5 fois le témoin, fibrinogène= 1g/l , Ferritinémie= 2000, CHT= 2g/l ; TG= 3 mmol/l

• **Vous suspectez quelle(s) complication(s) ?**

A. Leucémie aigue

B. Syndrome myélodysplasique

C. CIVD

D. Syndrome d'activation macrophagique

E. Anémie mégaloblastique

• **Vous suspectez quelle(s) complication(s) ?**

A. Leucémie aigue

B. Syndrome myélodysplasique

C. CIVD

D. Syndrome d'activation macrophagique

E. Anémie mégaloblastique

